

Pour le patient
de la vignette

Patient Chirurgie	Risque majeur	Risque intermédiaire	Risque mineur
	S. coronarien aigu IC décompensée Valvulopathie sévère Arythmie, tr. conduction sévère	Angor stable Infarctus (> 1 mois) IC compensée, IR, Diabète, Artériopathie, AVC	Age > 70 ans Arythmie HTA non contrôlée Tabac ↑ cholestérol
Stress majeur Aorte Foiie/pancréas/estomac Pneumectomie Transpl. hépatique	Différer l'intervention et programmer les examens cardiaques Classe I, B	Effort 4 MET et plus OK Chirurgie Classe IIa B	OK Chirurgie Classe I, B
Stress intermédiaire Vasculaire, Thoracotomie, Craniotomie, Chirurgie viscérale et gynéco, Orthopédie		Effort < 4MET (ou non évaluable) : Tests cardio Classe IIb B	
Stress mineur Endoscopie, Varices, Ophtalmologie, Sein, Paroi		OK Chirurgie Classe I, B	

Un homme de 57 ans doit subir une duodéno-pancréatectomie céphalique en raison d'une tumeur pancréatique. Dans ses ATCD on note un tabagisme actif à 40 UPA, un alcoolisme chronique, une hypertension artérielle traitée, ainsi qu'un infarctus myocardique inférieur ayant nécessité une angioplastie et stent il y a 3 ans. La tolérance à l'effort du patient est de 1 à 2 étages, limitée par la présence de DRS et de dyspnée.

Quel examen pré-opératoire permettra le mieux de stratifier le risque cardiaque de ce patient ?

- A. Un électrocardiogramme au repos (12 dérivations)
- B. Un dosage des Troponines I plasmatiques
- C. Un test de stress non invasif (scintigraphie ou écho de stress)
- D. Aucun examen ne permet de stratifier ce risque
- E. Une échocardiographie cardiaque transthoracique

Une patiente de 75 ans, connue pour une FA chronique, un ancien accident vasculaire cérébral, un diabète de type II insulino-traité, et une hypertension artérielle doit bénéficier d'une mise en place de prothèse totale de hanche en raison d'une coxarthrose sévère. Les médicaments suivants font partie de son ttt habituel.

Quel(s) médicament(s) doit(doivent) impérativement être arrêté(s) en pré-opératoire (TYPE K') ?

- A. Aténolol
- B. Rivaroxaban
- C. Insuline
- D. Oxazépam

Un patiente de 75 ans, connue pour une FA chronique, un ancien accident vasculaire cérébral, un diabète de type II insulino-traité, et une hypertension artérielle doit bénéficier d'une mise en place de prothèse totale de hanche en raison d'un coxarthrose sévère.

Quelles consignes lui donnez-vous pour le jeûne pré-opératoire?

- A. Stop aliments solides 6h et liquides clairs 2h avant la chirurgie
- B. Stop aliments solides 8h et liquides clairs 3h avant chirurgie
- C. Stop aliments solides et liquides 6h avant la chirurgie
- D. Stop aliments solides et liquides 8h avant la chirurgie
- E. Aucune réponse n'est correcte

Une femme de 32 ans est hospitalisée pour suspicion de grossesse extra-utérine. Une laparoscopie en urgence est indiquée.

Laquelle des techniques d'anesthésie suivantes est la plus judicieuse ?

- A. L'anesthésie générale avec intubation
- B. La rachi-anesthésie
- C. L'anesthésie péridurale continue
- D. L'anesthésie générale intra-veineuse au masque
- E. La sédation avec anesthésie locale

Un homme de 25 ans est admis aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite. L'examen clinique et les examens biologiques font suspecter une appendicite aiguë non perforée. Le patient souffre d'un asthme bronchique sévère mal stabilisé et exacerbé au moment de son admission. Il va être opéré sous anesthésie générale.

Quel agent inducteur anesthésique est particulièrement indiqué dans ce cas en raison de ses propriétés sympathomimétique et bronchodilatatrice ?

- A. propofol
- B. thiopental
- C. étomidate
- D. kétamine
- E. midazolam

Une patiente de 31 ans doit bénéficier d'une césarienne en extrême urgence sous anesthésie générale. Le médicament inducteur utilisé est le thiopental.

Quel effet secondaire attendu est lié à son utilisation comme inducteur d'anesthésie ?

- A. Des convulsions généralisées
- B. Une apnée de plusieurs minutes
- C. Une insuffisance rénale
- D. Un choc anaphylactique
- E. Une hépatite médicamenteuse

Un patient de 82 ans en bonne santé habituelle doit bénéficier d'une prothèse totale de hanche sous anesthésie générale. Il reçoit du midazolam en prémédication. En arrivant au bloc opératoire, le patient est agité, agressif et excité.

Quel est votre attitude ?

- A. Annuler l'intervention.
- B. Anesthésier rapidement le patient
- C. Administrer un anxiolytique
- D. Administrer un antidote
- E. Administrer un neuroleptique

Un patient de 35 ans en bonne santé habituelle doit subir une cure de hernie inguinale droite sous rachi-anesthésie.

Parmi ces propositions, quel accès veineux est le plus adéquat pour mettre en place une perfusion?

- A. Un accès veineux n'est pas nécessaire
- B. Un cathéter périphérique 18G au dos de la main
- C. Un cathéter périphérique 20G au pli du coude
- D. Un cathéter périphérique 20G au dos du pied
- E. Un cathéter périphérique 18G dans la jugulaire externe

Une femme de 29 ans, en bonne santé habituelle, est admise aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite. Un diagnostic d'appendicite aiguë non perforée est posé. La patiente va être opérée par laparoscopie sous anesthésie générale.

Parmi les éléments de monitoring décrits ci-dessous, quelle mesure s'avère superflue?

- A. La mesure du CO₂ expiré
- B. la mesure invasive de la pression artérielle
- C. la mesure de saturation en oxygène
- D. la mesure des pressions de ventilation
- E. la mesure de la fraction inspirée d'oxygène

Lors d'une anesthésie générale chez un patient intubé, le monitoring de la capnographie (analyse du CO_2 expiré) est obligatoire.

Parmi les problèmes suivants, lequel **ne peut pas être** détecté grâce au monitoring de la capnographie ?

- A. Une intubation œsophagienne
- B. Une ventilation minute insuffisante
- C. Une déconnexion du circuit de ventilation
- D. Une intubation sélective
- E. Une obstruction du circuit de ventilation

Chez un patient sous anesthésie générale, intubé, sous ventilation contrôlée avec une FIO₂ à 45%, vous effectuez une gazométrie artérielle qui montre : pH 7.30, pO₂: 150 mmHg (20 kPa), pCO₂ 52 mmHg (7 kPa), HCO₃ 25.5 mmol/l, SatO₂: 100%.

Comment s'appelle ce désordre acido-basique?

- A) Acidose métabolique
- B) Alcalose mixte
- C) Acidose respiratoire aiguë
- D) Acidocétose
- E) Acidose respiratoire chronique

Un patient de 55 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique sévère (GFR 15-25 ml/min), est opéré d'une prothèse totale de hanche.

Parmi les analgésiques suivants, le(s)quel(s) est/sont contre-indiqué(s) ? **TYPE K**

- A. Fentanyl
- B. Ibuprofène
- C. Morphine
- D. Buprénorphine

Une patiente de 27 ans est opérée d'une césarienne sous rachi-anesthésie (anesthésie spinale).

L'injection de l'anesthésique local dans le bon espace est confirmée par l'apparition progressive d' ?

- A. Une hypotension artérielle
- B. Un reflux de sang par l'aiguille
- C. Une bradycardie progressive
- D. Un bloc sensitif et moteur aux Mls
- E. Une paresthésie fugace aux Mls

Un patient de 80 ans s'est fracturé la hanche droite et doit bénéficier d'une hémiarthroplastie. Dans ses ATCD on note une maladie de Parkinson traitée, un diabète de type II et des épisodes d'hypotension orthostatique. Une rachianesthésie est effectuée. Peu de temps après la réalisation de l'anesthésie, le patient se sent étourdi et nauséeux. Sa pression artérielle est à 85/50 mmHg et sa fréquence cardiaque baisse progressivement à 50/min.

Quel est la cause la plus probable de ce tableau clinique ?

1. Une dysautonomie d'origine diabétique
2. Un bloc sympathique lié à la rachianesthésie
3. Une dysautonomie liée à la maladie de Parkinson
4. Une embolie graisseuse due à la fracture de la hanche
5. Un effet secondaire des anesthésiques locaux

Signes et symptômes d'intoxication systémique aux anesthésiques locaux

Signes neurologiques:

- Agitation
- Engourdissement péribuccal et linguale
- Goût métallique
- Acouphènes
- Dysarthrie
- Nystagmus
- Myoclonies
- CONVULSIONS

Signes cardiovasculaires:

- ↓ Résistances périphériques
- ↓ Débit cardiaque (dépression myocardique)
- Hypotension
- Ralentissement de la conduction cardiaque
- Arythmies
- ARRET CARDIAQUE

Une patiente de 70 ans, connue pour une poly-allergie aux antibiotiques et au latex ainsi que pour une maladie coronarienne stable doit être opérée d'une prothèse totale du genou sous anesthésie locorégionale de type bi-bloc fémoral et sciatique avec sédation. L'anesthésie du nerf sciatique se déroule sans problème. Lors de la réalisation du bloc du nerf fémoral elle signale des acouphènes, un goût étrange dans la bouche et de la difficulté à articuler. Sa pression artérielle chute et son rythme cardiaque devient irrégulier.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une ischémie myocardique
- B. Une réaction anaphylactique
- C. Une réaction vaso-vagale secondaire au bloc nerveux
- D. Un bloc sympathique étendu dû aux anesthésiques locaux
- E. Une toxicité systémique des anesthésiques locaux

l'adjonction concomitante d'épinéphrine (adrénaline) à un anesthésique local a pour but principal de :

- A. Retarder sa résorption tissulaire locale
- B. Contrecarrer une réaction allergique
- C. Diminuer le risque d'hypotension
- D. Limiter le risque de toxicité rénale
- E. Limiter la durée du bloc en activant les récepteurs alpha

Une patiente de 33 ans, G1P0, enceinte à 36 SA est admise en salle d'accouchement en raison d'une HTA 165/115mmHg (vérifiée à plusieurs reprises), de céphalées, d'une protéinurie +++, d'une hyperéflexie et de l'apparition d'importants œdèmes généralisés. Un déclenchement de l'accouchement est débuté.

La patiente désire une péridurale, quelle affirmation concernant cette technique est la plus juste dans cette situation ?

- A. Elle est contre-indiquée en raison du risque de thrombopénie
- B. Elle est médicalement indiquée en l'absence de contre-indication
- C. Elle n'est pas souhaitable car elle risque de ralentir le travail
- D. Elle est médicalement indiquée car elle diminue le risque d'éclampsie
- E. Elle n'est pas la meilleure technique pour soulager les douleurs liées au travail

Un patient de 60 ans vient de subir une chirurgie abdominale majeure. Les pertes sanguines ont été importantes ($>1500\text{ml}$), l'Hématocrite post-opératoire est à 21% ($\text{Hb}=70\text{ g/l}$), la PVC est basse, la diurèse horaire est de 10 ml/h malgré un remplissage peropératoire avec 5000 ml de cristalloïdes et 1000 ml de colloïdes.

Avec quel soluté poursuivez-vous le remplissage vasculaire en salle de réveil ?

- A. Des concentrés érythrocytaires
- B. De l'albumine à 20 %
- C. Du Ringer Lactate
- D. Du plasma frais congelé
- E. Du soluté glucosalin

Une perfusion de 2 litres de solution glucosée à 10% dans de l' H_2O , avec 100 mequ de Na^+ et 50 mequ de K^+ correspond environ à:

- A. 1675 kJ (400 kcal)
- B. 3350 kJ (800 kcal)
- C. 4190 kJ (1000 kcal)
- D. 6280 kJ (1500 kcal)
- E. 8375 kJ (2000 kcal)